

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos afectivos persistentes** (según DSM-5 y CIE-10) incluyen principalmente:

- **Trastorno depresivo persistente (Distimia)**
- **Trastorno ciclotímico (Ciclotimia)**

Ambos se caracterizan por alteraciones crónicas del ánimo que duran **años**, con síntomas **menos intensos pero más prolongados** que los de los episodios depresivos o maníacos clásicos.

La distimia y la ciclotimia son clínicamente relevantes porque:

- Constituyen un **importante factor de riesgo** para el desarrollo posterior de **depresión mayor o trastorno bipolar**.
- Se asocian con **baja productividad, deterioro interpersonal y riesgo suicida crónico**.
- Son **subdiagnosticadas**: los pacientes suelen “acostumbrarse” a sentirse mal o ser percibidos como simplemente “pesimistas” o “inestables”.

□ En el **EUNACOM**, estos cuadros suelen aparecer en preguntas de diagnóstico diferencial frente a depresión mayor o bipolaridad leve, o en escenarios de pacientes con síntomas crónicos pero sin episodios graves.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Distimia (Trastorno depresivo persistente)

Se asocia a **disminución de la serotonina y dopamina**, con alteraciones estructurales similares a la depresión mayor (hipocampo, corteza prefrontal).

Puede representar una **forma crónica de vulnerabilidad depresiva**, influenciada por:

- Factores genéticos (antecedente familiar de depresión o ansiedad).

- Personalidad con rasgos ansiosos o evitativos.
- Estrés psicosocial mantenido o trauma infantil.

2.2. Ciclotimia (Trastorno ciclotímico)

Considerada una **forma leve y crónica del trastorno bipolar**, con oscilaciones del ánimo que no cumplen criterios de manía o depresión mayor.

Su fisiopatología implica:

- **Inestabilidad dopaminérgica y glutamatérgica**, con alternancia de hiperactividad y agotamiento.
 - Alta carga hereditaria: **30–60%** evoluciona hacia trastorno bipolar tipo I o II.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Distimia (Trastorno depresivo persistente)

Criterios DSM-5:

- Ánimo deprimido la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante **≥2 años** (≥1 año en niños/adolescentes).
- Presencia de ≥2 de los siguientes síntomas:
 1. Poco apetito o sobrealimentación.
 2. Insomnio o hipersomnia.
 3. Baja energía o fatiga.
 4. Baja autoestima.
 5. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.
 6. Sentimientos de desesperanza.

Sin período asintomático mayor a 2 meses consecutivos.

Subtipos clínicos:

- **Pura:** síntomas persistentes sin episodios mayores.
- **Con episodios superpuestos:** depresión mayor intercalada (“doble depresión”).

Manifestaciones comunes:

- Fatiga constante, pesimismo, irritabilidad.
 - Dificultad para disfrutar (“anhedonia leve”).
 - Funcionamiento estable, pero con baja productividad.
 - En adolescentes: bajo rendimiento escolar, retraimiento, uso de alcohol.
-

3.2. Ciclotimia (Trastorno ciclotímico)

Criterios DSM-5:

- Durante ≥ 2 años (≥ 1 año en menores), presencia de numerosos **periodos de síntomas hipomaniacos y depresivos** que **no cumplen criterios completos** para manía ni depresión mayor.
- El paciente no está asintomático más de 2 meses consecutivos.
- No hay episodios maníacos, hipomaniacos ni depresivos mayores.

Clínica típica:

- Alternancia de periodos de **euforia leve** (más sociable, hiperactivo, confiado) con fases de **tristeza o apatía**.
- Gran **variabilidad emocional** e impulsividad.
- Frecuente **labilidad afectiva**, cambios de humor aparentemente “injustificados”.
- Conductas riesgosas leves durante fases hipomaniacas (gastos, sexualidad, decisiones impulsivas).

☐ El paciente con ciclotimia suele describirse como “inestable” o “de ánimo cambiante”, y suele acudir a consulta por conflictos interpersonales o laborales, más que por ánimo bajo.

3.3. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Depresión mayor	Episodios más intensos, duraderos semanas/meses, no crónicos.
Trastorno bipolar II	Episodios hipomaníacos definidos y depresivos mayores.
Trastorno de personalidad borderline	Cambios afectivos rápidos, reactividad interpersonal, vacío crónico.
Trastornos de ansiedad	Preocupación predominante más que alteración del ánimo.
Causas médicas (hipotiroidismo, anemia)	Alteraciones orgánicas objetivables.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes básicos para descartar causas orgánicas

Examen	Objetivo
TSH	Descartar hipotiroidismo
Hemograma	Anemia, enfermedad crónica
Glicemia, perfil hepático y renal	Evaluación basal antes de psicofármacos

4.2. Diagnóstico

- **Distimia:** cuadro depresivo leve, crónico (>2 años), con funcionalidad parcialmente conservada.
- **Ciclotimia:** fluctuaciones afectivas leves, sin criterios de bipolaridad plena, de al menos 2 años.

Requiere:

Descartar uso de sustancias o fármacos que expliquen la sintomatología (p. ej. corticoides, estimulantes, ansiolíticos).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El abordaje es **multimodal**, con enfoque biopsicosocial.

5.1. Distimia

Farmacoterapia (primera línea)

- **ISRS:** Sertralina, Fluoxetina, Escitalopram (igual que en depresión mayor).
- **IRSNa (Venlafaxina, Duloxetina)** si no hay respuesta tras 8 semanas.
- **Bupropión o Mirtazapina:** si predominan fatiga o hipersomnia.
- **Litio o lamotrigina:** en distimia resistente o con rasgos ciclotímicos.

Duración:

- Tratamiento de **al menos 12 meses** tras remisión completa.

Psicoterapia

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC):** reestructuración de patrones negativos persistentes.
 - **Terapia interpersonal:** mejora la regulación emocional y autoestima.
 - **Terapia de activación conductual:** refuerzo de rutinas gratificantes.
 - **Psicoeducación:** fundamental para mejorar adherencia y detección de recaídas.
-

5.2. Ciclotimia

Farmacoterapia

- **Estabilizadores del ánimo:**
 - **Litio:** primera línea en prevención de oscilaciones afectivas.
 - **Valproato o lamotrigina:** útiles si irritabilidad o hipomanía leve.
- Evitar ISRS en monoterapia (riesgo de viraje hipomaniaco).

Psicoterapia

- **Terapia cognitivo-conductual y psicoeducación familiar.**
- Técnicas de manejo emocional y prevención de recaídas.
- Regulación del sueño y manejo del estrés.

Estilo de vida

- Rutinas regulares de sueño y alimentación.
 - Evitar alcohol, estimulantes y privación de sueño.
 - Ejercicio aeróbico regular (efecto antidepresivo natural).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

Trastorno

Riesgos principales

Distimia Evolución a depresión mayor (“doble depresión”), aislamiento social, suicidio crónico.

Ciclotimia Evolución a trastorno bipolar I o II, abuso de sustancias, conflictos
a relacionales.

Pronóstico

- **Distimia:** curso crónico, con mejoría parcial. Respuesta favorable a psicoterapia + ISRS.
- **Ciclotimia:** 50% desarrollan bipolaridad plena en 5–10 años.
- Factores de mal pronóstico: comorbilidad ansiosa, falta de apoyo, pobre adherencia.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Duración ≥ 2 años** es clave para diagnosticar distimia o ciclotimia.
2. **Distimia = ánimo bajo crónico; Ciclotimia = fluctuaciones del ánimo.**
3. **Nunca tratar ciclotimia con ISRS en monoterapia.**
4. **Litio y lamotrigina** son útiles en pacientes con labilidad emocional persistente.
5. En distimia, la **TCC combinada con ISRS** es la intervención más efectiva.
6. En APS, preguntar por **periodos de “energía excesiva” o “buen ánimo anormal”** ayuda a descartar bipolaridad.
7. Pacientes con distimia suelen **minimizar sus síntomas**, por lo que la empatía y la psicoeducación son esenciales.



Errores comunes

- Diagnosticar depresión mayor sin considerar la **cronicidad (>2 años)**.
- Usar antidepresivos sin estabilizador en pacientes con oscilaciones afectivas.
- No indagar sobre **antecedentes familiares de bipolaridad**.
- Subestimar el **riesgo suicida en cuadros leves o “crónicos”**.
- No ofrecer psicoterapia estructurada o seguimiento prolongado.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Distimia**: ánimo deprimido crónico ≥ 2 años, síntomas leves pero persistentes.
2. **Ciclotimia**: fluctuaciones leves de ánimo durante ≥ 2 años, sin manía ni depresión mayor.
3. Ambas condiciones requieren **evaluación longitudinal y descartar bipolaridad**.
4. **ISRS + psicoterapia cognitivo-conductual** es tratamiento de elección en distimia.
5. **Estabilizadores del ánimo (litio, lamotrigina)** se usan en ciclotimia.
6. Son **trastornos GES en Chile**, manejables en APS con seguimiento.
7. La detección temprana previene la evolución a cuadros mayores y reduce el riesgo suicida.